

Herrn
Dr. med. Bernd Feldhaus
Facharzt für Allgemeinmedizin
Lindenstraße 8, 58998 Unterbachtal

Musterstadt, den 03.06.2026 · Aktenzeichen I2MUSTER / I2MUSTER

Entlassungsbrief

Erika Beispielmann, geb. 11.07.1951, Am Mühlgraben 4, 58998 Unterbachtal (Fallnummer: 900123456), Station 4.2

Sehr geehrter Herr Dr. med. Feldhaus,
die o. g. Patientin befand sich vom 12.05.2026 bis zum 03.06.2026 in unserer stationären Behandlung.

Diagnosen

- 1. Akut exazerbierte COPD (GOLD III, Gruppe E) mit hyperkapnischer respiratorischer Insuffizienz; intermittierend nichtinvasive Beatmung (NIV)
- 2. Ambulant erworbene Pneumonie rechts basal; antibiotische Therapie, Umstellung auf Piperacillin/Tazobactam
- 3. Kardiale Dekompensation bei chronischer Herzinsuffizienz mit reduzierter LV-Funktion (HFrEF, EF 35 %)
- 4. Neu diagnostiziertes normofrequentes Vorhofflimmern; Beginn oraler Antikoagulation (NOAK) bei CHA2DS2-VASc 5
- 5. Akute Verschlechterung einer chronischen Niereninsuffizienz (KDIGO G3b), im Verlauf regredient
- 6. Diabetes mellitus Typ 2, insulinpflichtig, HbA1c 8,1 %
- 7. Hypothyreose, substituiert
- 8. Sturz ohne Fraktur am 19.05.2026, Ausschluss intrakranieller Blutung

Vordiagnosen

Z. n. Nikotinabusus (40 py, sistiert 2019) · Z. n. Cholezystektomie 2008 · Arterielle Hypertonie · Presbyakusis

Entlassmedikation

Name (Wirkstoff)	Form	Dosierung	ab
Trimbow 87/5/9 µg	Inhalation	2-0-2 Hübe	22.05.2026
Salbutamol 100 µg	Inhalation	bei Bedarf, max. 8 Hübe/Tag	12.05.2026
Prednisolon 20 mg Tbl.	oral	1-0-0, ausschleichen: ab 08.06. 10 mg, ab 12.06. absetzen	30.05.2026
Apixaban 5 mg Tbl.	oral	1-0-1	25.05.2026
Bisoprolol 2,5 mg Tbl.	oral	1-0-0	26.05.2026

Torasemid 20 mg Tbl.	oral	1-0-0	31.05.2026
Ramipril 2,5 mg Tbl.	oral	0-0-1	29.05.2026
Insulin glargin 100 E/ml	s.c.	0-0-0-14 IE	12.05.2026
Metformin 500 mg Tbl.	oral	1-0-1 (Pause bei GFR < 30, s. Empfehlung)	01.06.2026
L-Thyroxin 75 µg Tbl.	oral	1-0-0 nüchtern	12.05.2026

Anamnese

Die Patientin berichtet über seit ca. einer Woche zunehmende Dyspnoe mit produktivem Husten und gelblichem Auswurf sowie neu aufgetretene Beinödeme. Bekannte COPD seit 2015 mit zwei Exazerbationen im Vorjahr. Zunehmende Belastungsdyspnoe (NYHA III). Kein Fieber zu Hause gemessen. Nikotinkarenz seit 2019.

Untersuchungsbefund bei Aufnahme

74-jährige Patientin in reduziertem Allgemein- und normalem Ernährungszustand. Pulmo: verlängertes Expirium, Giemen und Brummen bds., abgeschwächtes Atemgeräusch rechts basal mit feinblasigen RGs. Cor: arrhythmisch, normofrequent, 3/6-Systolikum über Erb. Periphere Ödeme bds. bis Mitte Unterschenkel. Abdomen weich, kein Druckschmerz. Neurologisch orientierend unauffällig.

Befunde

Labor bei Aufnahme (12.05.2026): CRP 148 mg/l, Leukozyten 14,2/nl, NT-proBNP 4.850 pg/ml, Kreatinin 1,9 mg/dl (GFR 28 ml/min), HbA1c 8,1 %, TSH 2,1 µU/ml. BGA (Raumluf): pO₂ 54 mmHg, pCO₂ 61 mmHg, pH 7,31.

Röntgen-Thorax (12.05.2026): Überblähung bds., Infiltrat rechts basal, Zeichen der pulmonalvenösen Stauung, Pleuraerguss rechts.

EKG (12.05.2026): Vorhofflimmern, HF 88/min, Linkstyp, keine akuten Ischämiezeichen.

TTE (15.05.2026): LV normal groß, EF biplan 35 %, diffuse Hypokinesie. LA dilatiert. MI I°, TI II° mit sPAP ca. 42 mmHg. Kein Perikarderguss.

Konsil Nephrologie (16.05.2026): Akut-auf-chronische Nierenfunktionsverschlechterung, a. e. prärenal bei Dekompensation. Empfehlung: vorsichtige Negativbilanzierung, Metformin pausieren, Retentionswerte alle 48 h.

CT Schädel nativ (19.05.2026, nach Sturz): Kein Nachweis einer intrakraniellen Blutung. Keine Fraktur.

Labor bei Entlassung (02.06.2026): CRP 22 mg/l, Kreatinin 1,4 mg/dl (GFR 38 ml/min), Kalium 4,2 mmol/l. BGA: pO₂ 63 mmHg, pCO₂ 49 mmHg, pH 7,38.

Verlauf

Die stationäre Aufnahme erfolgte bei akut exazerbierter COPD mit begleitender Pneumonie und hyperkapnischer respiratorischer Insuffizienz. Unter kalkulierter antibiotischer Therapie, systemischen Steroiden und intensivierter Inhalationstherapie sowie intermittierender NIV Besserung. Parallel kardiale Dekompensation bei erstdiagnostizierter HFrEF; unter i.v. diuretischer Therapie Negativbilanz von ca. 9 Litern. Elektrokardiographisch neu normofrequentes Vorhofflimmern; bei CHA₂DS₂-VASc 5 orale Antikoagulation mit Apixaban begonnen, Frequenzkontrolle mit niedrig dosiertem Betablocker. Initial akut verschlechterte Nierenfunktion unter Rekompensation regredient; Metformin passager pausiert, bei

Entlassung reduziert wieder angesetzt. Am 19.05. Sturz ohne Kopfanprall, CCT ohne Blutung. Wir entlassen Frau Beispielmann in deutlich gebessertem, stabilem Allgemeinzustand.

Therapieempfehlungen

Wir bitten um **Kontrolle der Retentionswerte und Elektrolyte in 5–7 Tagen** sowie um Wiederansetzen bzw. Dosisüberprüfung von Metformin nur bei GFR > 30 ml/min. Prednisolon bitte wie im Medikationsplan ausschleichen. Die Patientin ist angehalten, ihr **Gewicht täglich zu kontrollieren** (Meldung bei Zunahme > 2 kg in 3 Tagen); Trinkmengenbeschränkung auf 1,5 l/Tag. Wir bitten um **regelmäßige kardiologische Verlaufskontrollen mit Echokardiographie in ca. 3 Monaten** und ggf. Auftitration der Herzinsuffizienztherapie. Fortführung der oralen Antikoagulation mit Apixaban auf Dauer. **Pneumologische Anbindung** und Prüfung eines ambulanten Rehabilitationsantrags. Diabetologische Schulung ambulant empfohlen. HNO-ärztliche Vorstellung zur Hörgeräteversorgung. **Impfstatus prüfen** (Influenza, Pneumokokken, COVID-19-Auffrischung).

Mit kollegialen Grüßen

Prof. Dr. Ingrid Sommerfeld (Klinikdirektorin) · Dr. Jonas Wiegand (Oberarzt) · Selin Acar (Assistenzärztin)

Synthetisches Testdokument — keine echten Patientendaten. Alle Personen, Institutionen und Befunde sind erfunden.